



GUÍA EDUCATIVA PARA PACIENTES

Radiografías dentales durante el embarazo: lo que dice la evidencia moderna

Una explicación clara, basada en guías clínicas internacionales,
para que decidas junto a tu dentista con información real —
no con miedo.

Dr. Nicolás Guzmán

Cirujano Dentista · Concepción, Chile

Basado en evidencia

LA PREGUNTA

"Doc, ¿a las embarazadas no se les pueden tomar radiografías?"

Es una de las preguntas más frecuentes en la consulta — y una duda legítima. Esto es lo que dice la evidencia actual.

*Es un mito extendido, no una regla clínica. La respuesta moderna es clara: **sí se pueden tomar, cuando están realmente indicadas** — con los equipos y protocolos actuales, el riesgo es prácticamente insignificante.*

— Consenso de ADA (American Dental Association) y ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists)

EN RESUMEN

La atención dental — incluyendo anestesia local y radiografías cuando el caso lo requiere — es segura en cualquier momento del embarazo. Lo que cambia según la etapa no es "si se puede", sino qué tan conservador se es con lo electivo.

CÓMO SE ORGANIZA LA ATENCIÓN

Los tres momentos del embarazo

1º

Primer trimestre

Somos más conservadores. Se evita todo procedimiento electivo o no urgente, priorizando prudencia en la etapa de mayor desarrollo embrionario.

2º

Segundo trimestre

Es la ventana ideal. Aquí se concentra la mayoría de los tratamientos dentales necesarios, con la paciente más estable y cómoda.

3º

Tercer trimestre

Se prioriza la comodidad de la paciente y se evalúa la urgencia real del tratamiento antes de proceder.

Por qué existe tanta precaución si es seguro

Si el riesgo es tan bajo, ¿por qué tantas fichas técnicas y protocolos dicen "contraindicado en el embarazo"? La razón no es que sea peligroso — es ética de investigación.

1

No se experimenta en embarazadas ni en niños

Por principio ético, los procedimientos y medicamentos no se prueban en estudios experimentales con mujeres embarazadas o menores. Por eso muchas fichas técnicas dicen "contraindicado" por defecto: no es que exista evidencia de daño, es que no se generó evidencia de aprobación (FDA u otras agencias) en ese grupo.

2

Se trabaja con el principio ALARA

"As Low As Reasonably Achievable" — usar la menor radiación necesaria para responder la pregunta clínica, sin sacrificar el diagnóstico.

3

La tecnología actual redujo drásticamente el riesgo

Los equipos digitales usan dosis muy bajas de radiación. El haz se dirige directamente a la boca, no al abdomen, y la Asociación Dental Americana (ADA) actualizó en 2024 sus recomendaciones: el delantal de plomo ya no se considera necesario para proteger al paciente, porque la radiación dispersa es mínima con los equipos modernos.

Se dice	Lo que respalda la evidencia
"Ninguna radiografía dental durante el embarazo"	Son seguras cuando están clínicamente indicadas, en cualquier trimestre.
"Hay que usar delantal de plomo sí o sí"	Ya no es una recomendación obligatoria (ADA, 2024): los equipos digitales actuales acotan el haz a la zona necesaria.
"Mejor esperar hasta después del parto"	Postergar un diagnóstico puede dejar avanzar una infección — un riesgo mayor para la madre y el embarazo que la radiografía misma.

No es "¿se puede?" — es "¿está indicado?"

La odontología moderna no funciona con prohibiciones absolutas. Funciona evaluando riesgo, beneficio, momento del embarazo y necesidad real del tratamiento.

EL CRITERIO QUE IMPORTA

"¿Está realmente indicada esta radiografía para cuidar mejor a la mamá y al bebé?"

Más importante que evitar una radiografía necesaria es no dejar una infección sin diagnosticar. Una infección dental no tratada durante el embarazo es un riesgo documentado — la radiografía bien indicada es, muchas veces, la herramienta que la previene.



Qué revisamos antes de decidir

Historia clínica, trimestre actual, urgencia del síntoma, y si existe una alternativa diagnóstica igual de confiable con menor o ninguna radiación.



Qué comunicamos siempre

Por qué se indica (o no) la radiografía, qué alternativas existen, y qué pasa si se posterga — para que la decisión sea informada, no impuesta.

REFERENCIAS

- **American Dental Association (ADA)** — "Pregnancy", Oral Health Topics; y comunicado "ADA Releases Updated Recommendations to Enhance Radiography Safety in Dentistry" (2024).
- **American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)** — Committee Opinion N.º 569, "Oral Health Care During Pregnancy and Through the Life Span" (2013, reafirmado 2017).
- **FDI World Dental Federation** — "Oral Health and Pregnancy" Fact Sheet (2024) y "Policy Statement on Radiation Safety in Dentistry" (2014).

Este material es educativo y no reemplaza una evaluación clínica individual. Cada caso se evalúa según tu historia y contexto específico.

¿TIENES DUDAS SOBRE TU CASO?

Conversemos antes de que te llenes de dudas googleando

Si estás embarazada, planeas estarlo, o simplemente quieres resolver esta duda con criterio clínico y no con miedo — escíbeme directamente.

Cada consulta es distinta. Cuéntame tu situación y te oriento con base en tu caso, no en generalidades.

WA WhatsApp — wa.link/tu8qmu

W Sitio web — ndguzmanl.github.io/dr.guzman

IG Instagram — [@ndguzmanl](https://www.instagram.com/ndguzmanl)

Dr. Nicolás Guzmán · Cirujano Dentista · Aníbal Pinto 295, Edificio Buró, Of. 303, Concepción, Chile

Este documento se entrega como material educativo complementario a tu consulta dental. Última actualización: agosto 2026.